

FOTO: MAGNE EK

Værsågod, her er

Arbeidsplan for Pasientfokus

Stortinget 2021 - 2025





Kjære velgere!

Arbeidsplanen du nå holder i hånden inneholder noen temaer som Pasientfokus har jobbet med de siste fire årene. Vi holder fokus på pasienten og pasientens familie i Alta, Kautokeino og distriktene. Du finner vår arbeidsplan på norsk og på samisk.

Alta har de siste årene fått mange gode sykehustjenester. Det er vi i Pasientfokus glade for. Men de viktigste tilbudene, de som handler om selve livet mangler. Fødeavdeling, geriatrisk avdeling for våre eldre og et tidsriktig akuttilbud. Et slikt tilbud i Alta vil også styrke beredskapen for Kautokeino, Loppa, Kvænangen og Karasjok, med stengte veier vinterstid. Et sykehus til Alta vil gjøre livene enklere for de fleste, fra vugge til grav.

Hele Finnmark mangler et tidsriktig tilbud hvor pasientene alltid sendes til riktig sykehus og ikke omveien til et sykehus som ikke har fagkompetanse på for eksempel akutt hjerte- og hjerneinfarkt. Pasientfokus jobber for tre likeverdige sykehus til Finnmark.

Vi i Pasientfokus gjør ikke forskjell på folk. Uansett hvem du er, hva du tror på, ditt politiske ståsted, hva du gjør, om du er rik eller fattig, mann eller kvinne, ung eller gammel, gravid, fødende, bestemor eller bestefar, áhkku ja áddjá, oldemor og oldefar. Sakene vi har jobbet med – og skal jobbe med hvis vi kommer på Stortinget – angår deg og din familie. Pasienter i Norge har like rettigheter. Det finnes ingen unntak i lovene – heller ikke for pasienter i Alta, Kautokeino og distriktene i Finnmark.

Pasientfokus jobber for deg – sammen med deg.

Irene Ojala

1. kandidat for Pasientfokus



Saker vi jobber med, for deg

1. Fullverdig fødeavdeling til Alta.
Fra Alta til fødeavdelingen i Hammerfest er det 140 kilometer. Fra Kautokeino til Hammerfest er det 280 kilometer. Pasientfokus jobber for at kvinner fra Alta, Kautokeino og våre distrikter skal få føde sine barn i Alta. Ingen kvinner skal sendes alene, uten jordmorfølge, i privatbil i kolonne over fjellovergangen Sennalandet når fødsel nærmer seg. **Det må aldri skje!**



Innførte helseforetaksmodellen i 2002. AP ønsker å fjerne fritt behadlingsvalg hvis de kommer i regjering.

2. Fullverdig geriatrisk avdeling må etableres i Alta. De fleste eldre i Finnmark bor i Alta. Ingen eldre må dø i Hammerfest alene fordi veien over fjellovergangen Sennalandet er stengt, eller fordi familien ikke rakk fram. **Ensomhet for den døende er uakseptabelt.**

3. Tre – 3 - likeverdige sykehus i Finnmark. Finnmark er annerledesfylket. Politikere har gjort oss til unntaksfylket i forhold til norsk helselovgivning. Ingen pasienter med akutte skader/sykdommer i Finnmark skal sendes omveien til andre lokalsykehus i Finnmark, **men direkte til Universitetssykehuset, UNN, i Tromsø.**

4. Jordmormangel. I 2019 ble jordmormangelen i Norge beregnet til 200 årsverk. Jordmødre må få tilbud om heltidsstillinger. **Det må utdannes flere jordmødre, også samisktalende.**

5. Kautokeino er en av kommune i Finnmark som ligger mest avsides til i forhold til sykehus. Kautokeino kommune må bli en teleteknologisk foregangskommune for sykehustjenester i Finnmark. **Det som Kautokeino får av teknologiske tilbud må innføres på samtlige legevakter i Finnmark.**

6. Kautokeino må få beredskapsflyplass for ambulansefly. Sammenlignet med andre kommuner i Finnmark, med samme eller færre innbyggere, har Kautokeino dårligere beredskapstilbud. Det kan løses med fjernstyrt flytårn, etter modell fra Vardø, Mehamn og Værøy, styrt fra Bodø. Det er 280 kilometer fra Kautokeino til lokalsykehuset i Hammerfest. Med bil tar det over fire timer. **En beredskapsflyplass i Kautokeino vil skape trygghet for befolkningen.**



7. Avslutt praksisen med omlasting av pasienter fra en sykebil til en annen i hele Finnmark. I Vest-Finnmark har prehospital tjenester leid en garasje på Skaidi, cirka 50 kilometer fra lokalsykehuset i Hammerfest. Omlastingen tar mellom 15-18 minutter. Garasjen på Skaidi har ingen toalettfasiliteter for pasienten. **Må pasienten på do er løsningen bak garasjen!**

8. Sjåførbytte må innføres. Fram til Alta får fullverdig fødeavdeling, geriatri og akutt må det legges til rette for at ambulansebilene kan kjøre helt fram til Hammerfest uten omlasting av pasient. Det må innføres sjåførbytte mellom ambulansebilene. Dette i tråd med helseministerens oppdragsdokument 2018 – tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 85 S (2017-2018). «Helse Nord skal utrede en alternativ løsning for møtekjøring med ambulanse som innebærer sjåfør- og mannskapsbytte.» Denne saken kommer til behandling i stortingsperioden 2021-2025. **Der har vi i Pasientfokus mye å bidra med!**



9. Hurtigbåt mellom Alta og Hammerfest. Det er i dag to daglige hurtigbåtavganger fra Alta til Hammerfest med retur. Pasientfokus vil jobbe for en tredje avgang fra Alta med retur på formiddagen. En tredje avgang må ikke få negative konsekvenser for båttilbudet på kysten av Finnmark. En tredje avgang vil gi pasienter fra både Kautokeino og Alta kortere reisedager i forbindelse med sykehusbesøk. **Næringslivet og turisme i Hammerfest og Alta vil ha store fordeler av en ruteutvidelse.**

10. Bygging av ny flyplass på Grøtnes i Hammerfest kommune. Er det riktig å bruke 2,5 til fem milliarder kroner av samfunnets midler til en ny flyplass i en by som allerede har flyplass? Fødeavdeling, geriatri og akutt til Alta vil koste rundt 600 millioner kroner. Er samfunnet mest tjent med en ny flyplass på Grøtnes, for 11.000 mennesker, eller er det samfunnsøkonomisk og beredskapsmessig viktigere å gi livskvalitet og trygghet for rundt 30.000 mennesker i hele Alta-regionen inklusiv Loppa, Karasjok og Kvænangen? Kautokeino må få beredskaps flyplass og eventuell utvidelse til vanlig flyplass før etablering av flyplass til de som allerede har. **Utvidelse av hurtigbåtsambandet mellom Alta/Hammerfest/Alta vil gi et godt, tidsriktig og økonomisk tilbud for utvikling av næringslivet i hele Vest-Finnmark.**

11. E45 Kløfta. Pasientsikkerhet under transport av pasienter er svært viktig. Pasientfokus vil jobbe for en snarlig byggestart av ny vei gjennom Kløfta.

12. Ikke undervurder distriktslegenes faglige kompetanse! For å unngå prognosetap ved kritiske sykdommer som hjerte- eller hjerneinfarkt må leger i Alta, Kautokeino, Vardø og Finnmark for øvrig kunne sende pasientene raskest mulig til riktig behandlingssted uten omveien til et av lokalsykehusene i Finnmark. AMK skal ikke overstyre legenes beslutninger. **Det handler om pasientenes liv.**

13. Psykisk helse og rus. Det må opprettes flere akuttplasser for unge pasienter med psykiske lidelser i Alta. Det vil hele Finnmark tjene på. Det må ansettes flere psykiatere, slik at psykisk syke og rusavhengige får raskest mulig behandling. **Ettervern må ikke tidsbegrenses, men gis i henhold til pasientenes behov.**

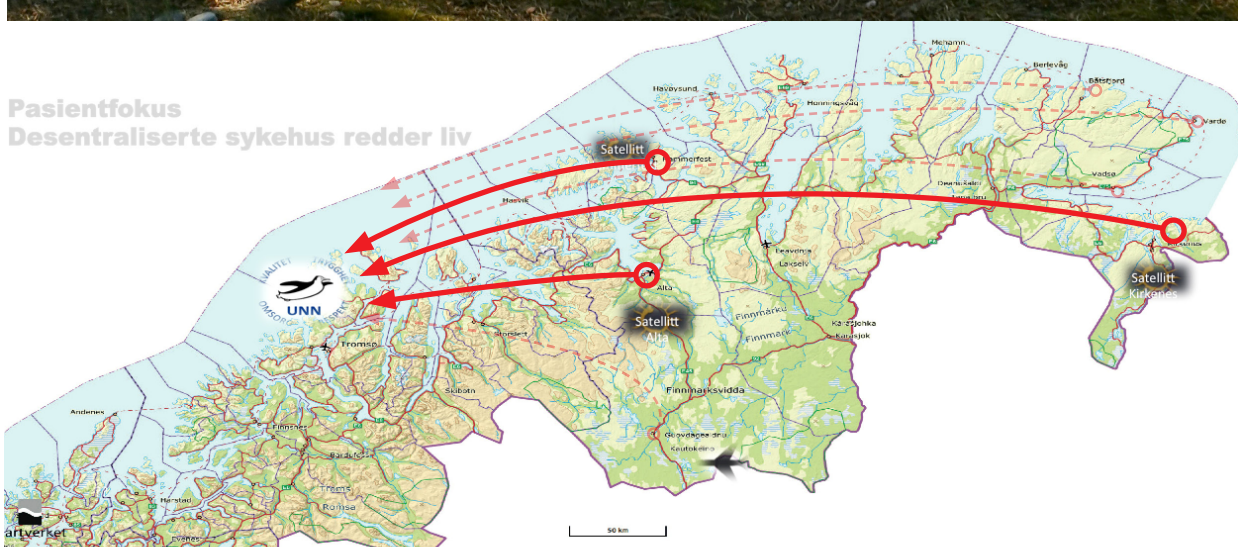
14. Opprettholde fritt behandlingsvalg! Fritt behandlingsvalg er viktig for distriktene i Norge. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling, kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo. Fordeler: Pasienter som ellers vil være sykemeldt en lengre periode, kan ved bruk av fritt behandlingsvalg, unngå prognosetap, kroniske helseproblemer og kommer raskere tilbake til jobb. **Samfunnsøkonomisk vil både arbeidstakere, arbeidsgiver og staten tjene på dette.**

15. Diverse behandlinger/forskning.
Forskning på kreft. Det må bevilges mer penger til forskning på kreftvaksiner. Eksempel prostatakreft.

16. Behandling av tenner/tannhelse. Undersøkelser og behandling av tenner må inn under samme egenandelstak som øvrige helsetjenester.

17. Styrke kompetansen på aldring og helse i utdanninga. Forskning viser at eldre som pasienter og brukere av helsetjenester, ikke er godt nok representert i forskrifter, fagplaner, studieemner og nasjonale rammeplaner. Det må innføres flere fordypningsemner om aldring og helse i videregående skoler, høgskoler, universiteter. **Det må legges vekt på samisk språk og kulturforståelse.**





18. Helsehavarikommisjon. I 2018 ble Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, Ukom, opprettet. Ukom har base i Stavanger, men har sine begrensninger, få ansatte og er økonomisk underfinansiert. Pasientfokus mener at en Helsehavarikommisjon må likestilles med Statens Flyhavarikommisjon, og må tre inn på samtlige alvorlige hendelser i de ulike helseforetakene i Norge.





HØYRE INNFØRTE UKOM I 2018.
Her er Sveinung Stensland (Helse- og omsorgskomiteen) og Marianne Haukland fra Høyre i samtale med Pasientfokus.



MØTE MED MAKTA:
Pasientfokus i møte med Helseminister Bent Høie.

19. Avviksrapportering sikrer pasientenes rettssikkerhet. Vi skal lære av feil- da kan ikke feil underkommuniseres. Ved feil behandling, eller manglende behandling, som fører til prognosetap eller død, må en uhildet Helsehavarikommisjon etterforske hendelsen.
Bekymringsmeldinger om avvik må undersøkes av Statsforvalter i et annet fylke enn det som helseforetaket ligger under i dag.

20. Fire permanente sykepleierutdanninger i Finnmark. Lokalisert til Kautokeino, Kirkenes, Alta og Hammerfest. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge vil trenge 28.000 sykepleiere i 2035. I tillegg må det utdannes flere leger, spesialistsykepleiere og annet helsepersonell.

21. Kompetanseheving. Ambulansetjenesten er pasientenes livline og sykehusets forlengede arm. Mange ambulansearbeidere etterspør tillegg/videre utdannelsesmuligheter på bachelornivå. Lønnsnivået må styrkes i takt med utdanningen og ansvaret. Vaktordningene må sikre ambulansearbeiderens rettigheter til hviletid, slik sikres også pasienten riktig behandling.

22. Finnmarkssykehuset må legges under Universitetssykehuset, UNN, i Tromsø. Saken skal behandles i neste stortingsperiode.
Hvis Pasientfokus kommer inn på Stortinget, vil vi delta i debatten og kan påvirke sykehusstrukturen til beste for pasientene.

23. Alle hjerte- og hjerneslag pasienter, uansett hvor de bor i Finnmark, må sendes direkte til Universitetssykehuset i Tromsø. Hvorfor? Tidstap må unngås! Finnmark har ikke fagkompetanse på hjerte- og karsykdommer. Når pasienter sendes omveien til lokalsykehus i Kirkens eller Hammerfest påføres tidstap, som påfører pasienter prognosetap, uførhet og tidlig død. Det kan ikke aksepteres! Hvordan gjennomføre dette? Nordlandssykehuset i Bodø må oppgraderes til fullverdig hjerteklinikk. Det vil si være operativ 24/7, inklusiv helg. Fullverdig hjerteklinikk i Bodø vil frigjøre behandling og sengekapasitet ved UNN i Tromsø. Disse sengene må tilbys pasienter fra Finnmark som trenger PCI-undersøkelser, utblokking av trange blodårer til hjertet. Pasientene må flys direkte til Tromsø. **Det gjelder fra samtlige kommuner i Finnmark.**





STATEN HAR ANSVAR FOR Å BYGGE SYKEHUS I NORGE.
Her selger Pasientfokus andelsbrev i til stiftelsen "Alta sykehus med Pasientfokus".

24. Helseforetaksmodellen må endres/skrotes. Innføringen av helseforetakene i 2002 har skapt store utfordringer for syke mennesker – særlig i distriktene. New Public Management har som formål å maksimere eiernes profitt. Det er staten som finansierer alle sykehustjenester i Norge. Et sykehus kan ikke gå med økonomisk overskudd. Foretaksmodellen har gjort økonomien til et mål, overordnet de helsefaglige hensynene. Her vil Pasientfokus jobbe tett med organisasjoner som Alternativ til helseforetaksmodellen.

25. Klimaansvar også for helseforetakene. Norske politikere har forpliktet seg til ulike internasjonale avtaler om reduksjon av klimagassutslipp. Det må være en sammenheng med politiske beslutninger og statens egen gjennomføring av klimatiltak i statlige og halvstatlige virksomheter. Det gjelder også for helseforetakene i Norge. De nye store sykehus som bygges i Norge vil føre til mer transport.

Vi i pasientfokus vil jobbe for at helseforetakene skal ta et større lokalt klimaansvar. I 2018 kjørte ambulansebilene i Finnmark 1.607.000 kilometer. I koronaåret 2020 ble 1.368.670 kilometer tilbakelagt. I tillegg kommer transport med fly og båt.

Dette er en statlig styrt klimafiendtlig handling. Det betyr at det må bygges flere sykehus der folk bor. Pasienter må sendes i riktig retning – aldri omveien til sykehus som ikke har kompetanse, for eksempel hjerte, hjerne og karsykdommer.



Áššit maiguin mii bargat du ovddas.

1. **Dievaslaš riegádahttinossodat Áltái. Álttás Hámmerfestii lea measta 140 kilomehtera.** Guovdageainnus Hámmerfestii lea 280 kilomehtera. Pasientfokus bargá dan nammii ahte nissonat Álttás, Guovdageainnus ja eará boaittobeale guovlluin galget beassat riegádahttet Álttás. Ii oktage nissonolmmoš galgga dárbbašit sáddejuvvot okto, jorttamovrra haga, priváhta biillain kolonnain Áisaroaivve bokte, go riegádahtten lea boađi boađi. Dat ii galgga dáhpáhuvvat!

2. **Dievaslaš geriatralaš ossodat ferte ásahuvvot Áltái.** Eanaš vuorasolbmot Finnmárkkus ásset Álttás. Ii oktage vuorasolmmoš galgga jápmit okto Hámmerfeasttas dan dihte go biilageaidnu Áisaroaivve badjel lea gitta, dahje jus bearaš ii ollen áiggil boahtit. Ii leat dohkálaš ahte jábmi olmmoš galgá leat okto!

3. **Golbma – 3- ovttadássásaš buohcceviesu Finnmárkui.** Finnmárku lea earálágan fylka. Politihkkarat leat dagahan min spiehkastatfylkan Norgga dearvvašvuođalága ektui. Ii oktage pasieantta gii fáhkka roasmmehuvvá/buohccá Finnmárkkus galgga vuos sáddejuvvot báikkálašbuohcceviesuide Finnmárkkus, muhto sáddejuvvot njuolgga Universitehtabuohccevissui, UNNii, Romssas.

4. **Jorttamovraváilivuohta.** 2019 meroštallojuvvui jorttamovraváilivuohta Norggas leat 200 jahkedoaimma. Jorttamovrat fertejit oažžut fálaldaga ollesáiggevirggiide. Lea dárbu eanet oahppan jorttamovrraide, maiddái geat sámástit.

5. **Guovdageaidnu lea okta suohkan Finnmárkkus mii lea doaresbealde buohcceviesu ektui.** Guovdageainnu suohkan ferte šaddat teleteknologalaš ovdamannisuohkaniin buohcceviessobálvalusaide Finnmárkkus. Dat maid Guovdageaidnu oažžu teknologalaš fálaldagain, galget maiddái ásahuvvot buot eará doaktárkantuvrraide Finnmárkkus.

6. **Guovdageaidnu ferte oažžut sadjái gearggosvuođagirdišilju ambulánsagirdiide.** Go buohtastahttá Guovdageainnu eará suohkaniiguin Finnmárkkus, gos leat seamma ollu dahje unnit ássit, de lea Guovdageainnus heajut gearggusvuođafálaldat. Dán sáhtášii čoavdit gáiddusstivrejuvvon girdidoartnain, seamma modealla mielde go Bådåddjo dál stivre gearggosvuođafálaldaga Várggáin, Donjevuonas ja Værøyas. Leat sullii 280 kilomehtera Guovdageainnus Hámmerfeasta báikkálaš buohccevissui. Billain dát mátki ádjána badjel njeallje diimmu. Gearggusvuođagirdišillju Guovdageainnus ásahivčči oadjebasdili álbmogii.

7. **Heaittihit práksisa Finnmárkkus gos pasieanttat sirdašuvvet ovtta ambulánsabiillas nubbái.** Oarje-Finnmárkkus leat prehospital nammasaš bálvalusat láigohan garaša Skáiddis, sullii 50 kilomehtera eret Hámmerfeastta báikkálaš buohcceviesus. Pasieanttasirdin ádjána sullii 15-18 minuhtta. Garášas Skáiddis eai leat hivssegat pasieanttaid várás. Jus pasieanttas lea hivssetdárbu, de šaddá čegŋet garaša duohkai!

8. **Vuddjiidlonohallan ferte ásahuvvot.** Dassážii go Áltái ásahuvvo ollislaš riegádahttin-, geriatriija- ja fáhkkatlašossodat, de fertejit láhčit dili nu ahte ambulánsabiillat sáhttet vuoddjit gitta Hámmerfestii nu ahte pasieanttaid eai sirdde ovtta biillas nubbái. Ferte ásahuvvot vuoddjilonuheapmi ambulánsabiillaid gaskkas. Dát lea dearvvašvuođaministara liigedokumeantta 2018 mielde man Stuoradiggi meannudii Prop. 85 S (2017-2018). “Davvi dearvvašvuohta galgá suokkardit molssaevttolaš čovdosa ambulánssaide mat šaddet lonuhit bargiid”. Dát ášši galgá meannuduvvot 2021-2025 stuorradiggeáigodagas. Pasientfokus bealis sáhttit veahkkin dán barggus.
Leaktofanas gaskkal Álttá ja Hámmerfeastta. Odne johttá leaktofanas guktii beaivái Álttás Hámmerfestii ja máhccá fas ruovttoluotta. Pasientfokus áigu oččodit dán fálaldaga viiddiduvvot nu ahte šaddet golbma leaktofanas tuvrra beaivái, ja nu ahte oktii beaivái máhccá Áltái ovdalgaskabeaivvi. Goalmmát fanasfálaldat ii čuoza eará fanasfálaldatruvttuide Finnmárkku rittus. Goalmmát fanasfálaldat attášii Guovdageainnu, Álttá ja eará boaittobeale báikkiid pasieanttaide oanehit mátkkoštanbeivviid. Dát viiddideapmi boahtá maid buorrin Hámmárfeastta ealáhussii ja turismaealáhussii.

9. **Leaktofanas gaskkal Álttá ja Hámmerfeastta.** Odne johttá leaktofanas guktii beaivái Álttás Hámmerfestii ja máhccá fas ruovttoluotta. Pasientfokus áigu oččodit dán fálaldaga viiddiduvvot nu ahte šaddet golbma leaktofanas tuvrra beaivái, ja nu ahte oktii beaivái máhccá Áltái ovdalgaskabeaivvi. Goalmmát fanasfálaldat ii čuoza eará fanasfálaldatruvttuide Finnmárkku rittus. Goalmmát fanasfálaldat attášii Guovdageainnu, Álttá ja eará boaittobeale báikkiid pasieanttaide oanehit mátkkoštanbeivviid. Dát viiddideapmi boahtá maid buorrin Hámmárfeastta ja Álttá ealáhusaide ja turismii.

10. **Ođđa girdišiljohuksen Grøtnesii Hámmerfeasttas.** Lea go riekta atnit 2,5 gitta vihtta miljárdda ruvnno servodaga ruđain ođđa girdišilju gávpogii gos ovddežis jo lea girdišilju? Riegádahtten-, geriatriija- ja fáhkkatlašossodat Áltái máksá 600 miljárdda ruvnno. Lea go servodahkii eanet ávkin huksehit ođđa girdišillju Grøtnesii ja 11 000 olbmui, vai lea go servvodatekonomiija ja gearggosvuođadustehusa ektui eanet jierpmálaš nannet eallinkvalitehta ja oadjebasvuođa birrasii 30 000 olbmui Áltá-regiovnnas mii fátmmasta Láhpi, Guovdageainnu ja Návuona. Guovdageaidnu ferte oažžut gearggusvuođagirdišillju ja vejolašvuođa viiddidit dábálaš girdišilljun ovdal go ásahit ođđa girdišiljuid dohko gos ovdalis jo leat girdišiljut. Leaktofanasoktavuođa nannen gaskkal Álttá/Hámmerfeastta/Álttá addá buori, áigeguovdilis ja ekonomalaš fálaldaga ovdánahttet Oarje-Finnmárkku ealáhusaide.

11. **E45 Silisávži.** Pasieanttasihkkarvuohta pasieanttaid fievrredeamis lea dehálaš ášši. Pasientfokus áigu bargat jođánit oažžut hukset ođđa geainnu Silisávžži čađa.

12. **Allet fuonáš guovlludoaktáriid fágalaš gelbbolašvuođa!** Go galgá eastadit buozalmasvuođa vearráneami nugo infárkka váimmus ja vuoiŋŋamaččain, de fertejit doaktárat Álttás, Guovdageainnus, Várggáin ja muđuid Finnmárkkus beassat sáddet pasieanttaid jođáneamos vugiin rivttes divššohahkii garvin dihte liigemátki báikkálaš buohccevissui Finnmárkkus. AMK ii galgga gomihit doaktáriid mearrádusaid. Dás lea sáhka pasieanttaid eallimis.

13. **Psyhkalaš dearvvašvuohta ja gárrenmirkkoheavaheapmi.** Fertejit ásahuvvot eambbo fáhkkatlášsajiid nuorra pasieanttaide geat gillájit psyhkalačča t. Dat livčči ávkin olles Finnmárkui. Fertejit virgáduvvot eanet psykiatarat, nu ahte psyhkalaš buohccit ja sii geat leat darvánan gárrenmirkkuide ožžot divššu jođáneamos lágiin. Čuovvulanveahkki maŋŋel divššu ii galgga dušše fállojuvvot dihto áigái, muhto addot pasieantta dárbbuid mielde.





ER REINDRIFT ET FARLIG YRKE?
Reindriftsutøveren jobber om vinteren ofte langt fra nærmeste vei, med dårlig mobildekning, og ingen akutt-beredskap, i temperaturer ned mot minus 40.

14 . **Doalahit friddja divššohatválljenvejolašvuođa!** Dikšoválljenfriddjavuohta lea dehálaš Norgga boaittobeale guovlluide. Pasieanttat geain lea riekti dearvvašvuođaiskkadeapmái, sáhttet válljet oažžut divššu juogo almmolaš divššohagain dahje priváhta divššohagain main lea šiehtadus Helfoin. Ovdamunit: Pasieanttat geat muđuid sáhttet gártat leat buohccindieđihuvvot guhkit áigái, sáhttet friddja divššohatválljenvejolašvuođain eastadit buozalmasvuođavearráneami, kronalaš dearvvašvuođaváttisvuođaid ja nu beassat árabut máhccat bargui. Dát lea servodatekonomalačča ávkin sihke bargái, bargoaddái ja stádii.

15. **Iešguđetlágan divššut/dutkamat. Borasdávdda dutkan.** Dat ferte juolluduvvot eanet ruhta borasdávdavaksiinnaid. Nu go ovdamearkka dihte ovdaráksáborasdávdii.

16. **Bátnedikšu/bátnedearvvašvuohta.** Bátneiskkadeamit ja divššut fertejit fátmmastuvvot seamma iešmáksorádjeortnegii go eará dearvvašvuođabálvalusat.

17. **Nannet boarásmuvvama ja dearvvašvuođa gelbbolašvuođa oahpuin.** Dutkamat čájehit ahte vuorrasat pasieanttat ja dearvvašvuođabálvalusa geavaheaddjit eai olus namuhuvvo láhkaásahusain, fágaplánain, oahppoovttadagain ja nationála rámmaplánain. Fertejit ásahuvvot čieknudanfáttát boarásmuvvama ja dearvvašvuođa birra joatkkaskuvllain, allaskuvllain ja universitehtain. Sámi kultuvra ja giellamáhttu ferte maiddái vuoruhuvvot.

18. **Dearvvašvuođahavariijakommišuvdna. 2018 ásahuvvui Ukom, Stáda guorahallankommišuvdna dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalus.** Ukom lea Stavangeris, muhto doppe leat unnán bargit ja sii ožžot unnán ruhtadeapmi. Dán dihte oaivvilda Pasientfokus ahte Dearvvašvuođahavariijakommišuvdna galgá leat ovttadássásaš Stáda girdihavariijakommišuvnnain, ja galgá guorahallat buot duođalaš dáhpáhusaid daid iešguđet dearvvašvuođaovttadagain Norggas.

19. **Spiehkastatraporteren sihkkaraste pasieanttaid riektesihkarvuođa.** Mii galgat oahppat boasttuvuođain, ja de fertet hupmat dáid birra. Vearu dahje váilevaš dikšu, mii dagaha buozalmasvuođavearráneami dahje jápmima, ferte sorjjasmeahttun Dearvvašvuođahavariijakommišuvdna guorahallat dáhpáhusa. Go olbmot dieđihit vuorjašumiid, de dát fertejit guorahallojuvvot Stádahálddašeaddjis mii lea eará fylkkas gos vuorjašupmi lea dieđihuvvon.

20. **Njeallje bistevaš buohccidivššároahppobáikkit Finnmárkkus.** Oahppobáikkit leat Guovdageainnus, Girkonjárggas, Álttás ja Hámmerfeasttas. Statistihkalaš guovddášdoaimmahaga logut čájehit ahte Norga dárbbaša 28 000 buohccidivššára 2035. Lassin lea dárbu eanet oahppan doaktáriidda, spesialisttabuohccidivššáriidda ja eará dearvvašvuođabálvalusbargiide.

21.**Gelbbolašvuođanannen Ambulánsabálvalusas.** Ambulánsabargit leat dorvun pasieanttaide ja buohcceviesuid olgeš giehtan. Olu ambulánsabargit ohcalit lassi oahppovejolašvuođaid bachelordásis. Bálkádássi ferte nannejuvvot oahpu ja ovddasvástádusa mielde. Bargovuorut fertejit sihkkarastit ambulánsabargiid rievtti vuoiŋŋastanáigái.

22. **Finnmárkku buohcciviessu galgá Davvi-Norgga Universitehtabuohcceviesu, UNNa, stivrejumi vuollai.** Ášši galgá meannuduvvot boahtte stuorradiggeáigodagas. Jus Pasientfokus beassá Stuorradiggái, de mii oassálastit debáhtas ja sáhttit váikkuhit buohcceviessostruktuvrii buoremussan pasieanttaide.

23. **Buot váibmo- ja vuoiŋŋamašpasieanttat, beroškeahttá gos Finnmárkkus ásset, galget sáddejuvvot njuolgga Davvi-Norgga Universitehta buohccevissui Romssas.** Manne? Áigesuollagiid ferte hehttet! Finnmárkkus ii leat fágagelbbolašvuohta váibmo- ja vuoiŋŋamašbuozalmasvuođain. Go pasieanttat sáddejuvvojit liigemátkkiin juogo Girkonjárgga dahje Hámmerfeastta báikkálaš buohccevissui, de dát dagahit ahte áigi gollá ja pasieanttaid dearvvašvuohta vearáska, bargonávccahisvuođa ja árra jápmima. Dát ii leat dohkálaš! Mo dán čađahit? Norlánda skippijviesso Bådådjos ferte ođasmahttojuvvot dievaslaččat váibmoklinihkkan. Dát mearkkaša ahte galgá leat doaimmas birra jándora, maiddái vahkkoloahpaid.
Dievaslaš váibmoklinihkka Bådådjos dagaha ahte UNN buohcceviesus Romssas luvve seaŋgasajiid ja áiggi divššuide. Dát seaŋgasajit fertejit fállot pasieanttaide Finnmárkkus geat dárbbašit PCI-iskosiidda gos rahpet buđđosan varrasuonaid váimmus. Pasieanttat galget girdin fievrreduvvot njuolgga Romsii. Dát guoská buot Finnmárkku suohkaniidda.

24. **Dearvvašvuođaovttadatdoaibmamodealla ferte rievdaduvvot/heaittihuvvot.** Dearvvašvuođaovttadatdoaibmamodealla ásaheapmi 2002:s lea mielddisbuktán stuora hástalusaid buohcci olbmuide, earenoamážit boaittobeale guovlluin. New Public Management ulbmil lea nannet eaiggádiid dietnasa. Stáda ruhtada buot buohcceviessobálvalusaid Norggas. Buohcceviesus ii galgga báhcit ruđalaš badjelbáza. Ovttadatdoaibmamodealla lea dagahan ekonomiija váldoulbmilin ovdalii dearvvašvuođafágalaš áššiid. Dákko dáhttu Pasientfokus nannosit bargat organisašuvnnain Alternativ til helseforetaksmodellen.



25. **Dearvvašvuođaovttadagain lea maid dálkkádatovddasvástádus.** Politihkkárat Norggas leat geatnegahtten čuovvut iešguđet riikkaidgaskasaš šiehtadusaide geahpidan dihte dálkkádatgássaid. Dat ferte leat čielga čanastat gaskkal politihkalaš mearrádusaid ja das mo stáhta ieš čađaha dálkkádatdoaimmaid stáda iežas doaimmain, muhto maiddái doaimmain gos stádas leat ossosat. Dát guoská maiddái Norgga dearvvašvuođaovttadagaide. Dat ođđa buohcceviesut mat huksejuvvojit Norggas mielddisbuktet eanet fievrredemiid. Pasientfokus bealis áigut bargat oččodit dearvvašvuođaovttadagaid váldit stuorit dálkkádatovddasvástádusa báikkálaččat. 2018 vudje ambulánsabiillat Finnmárkkus 1607 000 kilomehtera. Koronajagis 2020:s vuddje 1368 670 kilomehtera. Lassin ledje vel fievrredeamit girdiiguin ja fatnasiiguin. Dát lea stáda bealis heajos dálkkádatstivrejupmi. Dát mearkkaša ahte fertejit huksejuvvot eanet buohcceviesut dohko gos olbmot ásset.
Pasieanttat fertejit sáddejuvvot njuolgga rievttes báikái, eaige sáddejuvvot liigemátkkiid mielde buohcceviesuide gos ii leat fágagelbbolašvuohta nugo omd. váibmo-, vuoiŋŋamaš- ja varrasuotnadávddaide. Riegádahttinossodagat fertejit ásahuvvot doppe gos nissonolbmot ásset – dát nanne ássanmovtta ja eleš servodagaid.



Stortingslista til Pasientfokus

Sommeren 2017 inviterte Irene befolkningen i Alta og Kautokeino til å bli med i Postkortaksjonen.

Målet var å påvirke politikere på Stortinget og i regjering om å si ja til konsekvensutredning av sykehusstrukturen i hele Vest- Finnmark. I desember 2017 stemte Stortinget nei til kunnskap. Fire års arbeid for fødeavdeling, geriatri og akuttavdeling i Alta er bakgrunnen for at Pasientfokus ble oppfordret til å stille liste til Stortingsvalget 2021 – 2025. Like før påske 2021 bestemte vi oss for å stille oss til rådighet. Her er en presentasjon av listekandidatene til Pasientfokus, stortingsvalget 2021-2025:

1. kandidat
Irene Ojala



Irene er leder i den frivillige organisasjonen Pasientfokus og stiftelsen Alta sykehus med Pasientfokus. Hun er opprinnelig fra Kiberg i Vardø kommune. Og bor i Alta/ Bodø. Irene har bakgrunn fra helse og omsorgstjenesten, reiseliv og servicenæring. Irene er samfunnsplanlegger med Bachelor i Nordområdestudier, fra University of the Arctic. Irene har videreutdanning i sosiologi og statsvitenskap med fordypning i ressursforvaltning, flerkulturelle studier og økologisk økonomi.

«Erfaringer fra tre trøblete svangerskap, to yrkesskader, pårørende til syke foreldre og en eldre utviklingshemmet bror har lært meg at utfordringer som svært mange opplever, ofte ikke blir snakket om. Dagens helse- og sykehussystem har ført til at det å være syk, eller utviklingshemmet, blir en livslang oppgave for hele familien. Vi må finne løsninger slik at livskvaliteten er god også når sykdom, eller funksjonsnedsettelse, blir en del av dagliglivet. Lange unødvendige reiser for eldre, fødende og akutt syke, stjeler helsa til folk og er ikke forenelig med likeverd og respekt for mennesker i sårbare situasjoner.»

2. kandidat
Klemet Erland Hætta



Klemet bor i Máze i Kautokeino kommune. Han har bred politisk erfaring fra fylkestinget og Sametinget og har vært ordfører i Kautokeino i 12 år. I dag jobber Klemet som seniorrådgiver for Troms og Finnmark Bondelag.

Klemet er opptatt av et godt helsetilbud for alle – fordi det er noe alle vil nyte godt av. Det er 70 kilometer fra Máze til kommunesentret Kautokeino og 280 kilometer fra Kautokeino til lokalsykehuset i Hammerfest. Når noen blir syk rykker førstehjelpsgruppa, som Klemet er medlem i, ut og gir akutthjelp mens man venter på ambulanse. Fritiden går med til «Friluftsliv, matlaging, jakt og fiske.»

3. kandidat
Leif Gøran Vasskog



Leif Gøran er fra Alta og bor på hjemgården i Tverrelvdalen. Han er utdannet ingeniør og siviløkonom og jobber i dag i Vegdirektoratet. «Jeg er opptatt av gode sykehustjenester, utjevning av sosiale forskjeller i samfunnet, samferdsel og grønt skifte.»

4. kandidat
Unn-Hariet Vekve



Unn-Hariet er fra Storekorsnes i Alta Kommune, men bor i Alta. Hun har bakgrunn fra servicenæringen og arbeid med barn og unge i Alta kommune. Unn-Hariet har jobbet i Pasientfokus siden starten i 2017. Hun sitter i styret for Pasientfokus og i stiftelsen Alta sykehus med Pasientfokus.

5. kandidat
Sara-Kristine Loso



Sara-Kristine er fra Kautokeino. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og har videreutdanning i helseledelse. Hun har lang erfaring fra klinisk sykepleie og har bred erfaring innenfor kommunal- og spesialisthelsetjeneste. I dag jobber Sara-Kristine som virksomhetsleder psykisk helse i Alta kommune.

6. kandidat
Anna Kristine Sokki Bongo



Anna er fra Kautokeino. Hun er reindriftsutøver sammen med sin mann. Anna er utdannet sykepleier med 20 år i helse-og omsorgstjenesten. I tillegg til reindrift jobber Anna i dag som HMS rådgiver i reindriften og er tilknyttet et 3. årlig prosjekt for å styrke helse, miljø og sikkerhet i reindriften.

7. kandidat
Mariann Smith-Novik



Mariann er fra Alta. Hun jobber til daglig som psykologspesialist ved Bup. Mariann ble med i Pasientfokus fordi lange transportveier for gravide og syke barn/ voksne/ eldre medfører unødvendige lidelser, tap av helse og noen ganger tap av liv. Dette må endres. «Det er viktig å lytte til pasienter. Det er viktig at pasienten og helsepersonell samarbeider. Det gir helsegevinst til beste for pasienten.»

8. kandidat
Bjørn Einar Lyng



Bjørn Einar er fra Alta. Han har jobbet i reiseliv, SAS og Widerøe i 36 år. Han har lang fartstid i lokalpolitikken i Alta med hele 36 år i Alta kommunestyre før han takket av. Bjørn Einar er far til fire barn og har ett barnebarn. «Det viktigste vi kan gjøre er å jobbe for fødeavdeling, akutt og geriatri til Alta. Det er ingen alternativ – vi må ta vare på folk.»

9. kandidat.
Bengt Stabrun Johansen



Bengt kommer fra Loppa kommune, men har vært bosatt i Alta siden 1995. Politikk har vært en del av livet – og Bengt har tre perioder i Alta kommunestyre hvor av to som fast medlem, og en periode som første varamedlem.
Har sittet i formannskap og div politiske utvalg.
Har også erfaring fra Fylkesting og fylkeskommunale utvalg. Bengt jobber til daglig som tømrerbas i Alta.

10. kandidat
Fredbjørg Nicolaysen



Fredbjørg er opprinnelig fra Øksfjordbotn i Loppa kommune. Hun har sin utdanning som spesialpedagog/ logoped, fra Universitetet i Oslo. Hun har sin privatpraksis i Alta. Pasientene kommer fra Loppa, Nord-Troms, Kautokeino og Alta. «Pasientene jeg behandler har ulike sykdommer som kreft, slagrammede, Parkinson, stamming og/ eller stemmevansker for å nevne noen sykdommer mine pasienter sliter med.» «Jeg er med i Pasientfokus fordi jeg mener at alle har krav på likeverdig behandling – også pasienter jeg jobber med fra ulike deler av Alta-regionen. Jeg ser det hver eneste dag – at ting ikke fungerer. Blant annet går det for lang tid for slagpasienter å få hjelp.

Hvem er Altaværingene?

Folk i Alta er de som har bodd innerst i Altafjorden i generasjoner. 6000 bilder i berg i Hjemmeluft, Alta, viser det. Det nære samarbeide med nabokommunen Kautokeino har knyttet familiebånd mellom indre fjordstrøk og Kautokeino i generasjoner. Kvinner har født barn og eldre har endt sine liv ved fjorden. "Halve Alta består av innflyttere fra andre steder i Finnmark." Det betyr at det er mange som har familier på kysten av Finnmark. Og har Altafolk familier på kysten – da har også kystens folk familier i Alta. Fødeavdeling, akutt og geriatri vil med andre ord skape trygghet som ringvirkninger til store deler av Finnmark.

Du har nå lest Pasientfokus sin arbeidsplan.
Vi jobber for, og har tru på demokratiet. Vi kan ikke unnlate å si fra når syke folk ikke blir tatt på alvor. For oss i Pasientfokus er syke eldre, fødende kvinner og akutt syke mennesker sine rettigheter ikke en tapt sak. Folk i Alta, Kautokeino og distriktene skal leve gode liv med livskvalitet, ikke overleve grunnet flaks.
I det ligger forskjellen.

Pasientfokus ønsker deg med dette; godt valg! Det er du som bestemmer!

Pasientfokus

For flokken vår
i Alta, Kautokeino og distriktene

Tlf. 986 04 632
Mail: ireojala@gmail.com / irene@pasientfokus.no
Nettside: pasientfokus.no
Org.nr. 920614310

Støtt Pasientfokus!
Vipps 669043 / Kontonr. 4901 16 74908